EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66770
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-02 11:07:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN HECTOR ZU◆IGA MEDEL			RUN	: 7.409.901-7
F.Nac	: 20-11-1954	Edad	: 68 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: 11 DE SEPT MANZANO 849			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 30-06-2023	Fecha Egreso	: 2023-07-02 11:07:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N41.0-PROSTATITIS AGUDA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Prostatitis aguda en tratamiento
AKI en resolucion
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N41.0-PROSTATITIS AGUDA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec de HTA, consulta el 30/06 por cuadro de 2 dias de evolucion de disuria, algia hipogastrica, oliganuria, pujo y tenesmo vesical. A la examinacion fisica abdominal se describe dolor a palpacion en region hipogastrica
Examenes de lab al ingreso -> glicemia 118; crea 1,7 (prev 1,1); LDH 196; lactato 1; PCR 269,6; uremia 55; Na/K/Cl 136/4.3/101; Hb/Hcto 13.5/39.1; Gb 16,5; plaq 266000; segment 81%; INR 1,15; PSA 22,64; orina de aspecto semi turbio, 80 ery/uL; 15 leu/uL
PieloTAC 30/06 sin hallazgos patologicos
Se decide ingreso para terapia ATB
Durante estadia se inicia ATB de amplio espectro, con buena respuesta, sin peak febril durante estadia
Paciente evoluciona estable, afebril, sin algia abdominal actual, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, actualmente sin disuria.
Examenes de lab control -> glicemia 113; crea 1,4 (prev 1,7; PCR 156; uremia 43; Na/K/Cl 138/3,9/107; Hb/Hcto 13.1/38.7; Gb 5,6; plaq 306000; segment 67%
Ex fisico -> Vigil, OTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BD, disendido, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 2 hospitalizado, dia N° 2 ceftriaxona, en condiciones de continuar con hospitalizacion y seguimiento de caso desde HODOM

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios a la baja, se continuara con dosis ATB establecida, se continuara manejo de paciente via HODOM, se controlara con examenes de lab dentro de 48 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 5 dias
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 5 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 5 dias si dolor y/o T° ax > 37,8°C
6. Examenes de control 04/07

Daniel Acevedo Pereira
Médico Cirujano
18.431.829-6

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO